

Les nouveaux critères ISTH 2025 améliorent-ils le diagnostic de la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ?

Dr Kacem M., Pr Bounaas S.
Service d'Hémodiologie et Transfusion Sanguine, CHU Sétif



INTRODUCTION

La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) demeure une complication grave, associée à une morbi-mortalité élevée, notamment en contexte de sepsis.

Les critères ISTH de 2001, bien validés, ciblent surtout les formes décompensées et manquent de sensibilité pour un diagnostic précoce.

En 2025, l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) a proposé une révision majeure, redéfinissant la CIVD comme un processus dynamique et adaptant les critères à l'étiologie sous-jacente.



MÉTHODES

Une synthèse de la littérature (2011–2025) a été réalisée à l'aide de la plateforme d'analyse bibliographique Consensus.app, incluant :



Méta-analyses



Cohortes prospectives multicentriques



Communications officielles de l'ISTH comparant les scores ISTH, SIC, JAAM et DIC-JSTH



RÉSULTATS



Les critères 2025 introduisent une définition phasée (précoce/patente) et une approche à deux temps.



Amélioration de la détection précoce de la coagulopathie comparativement à l'ISTH 2001.

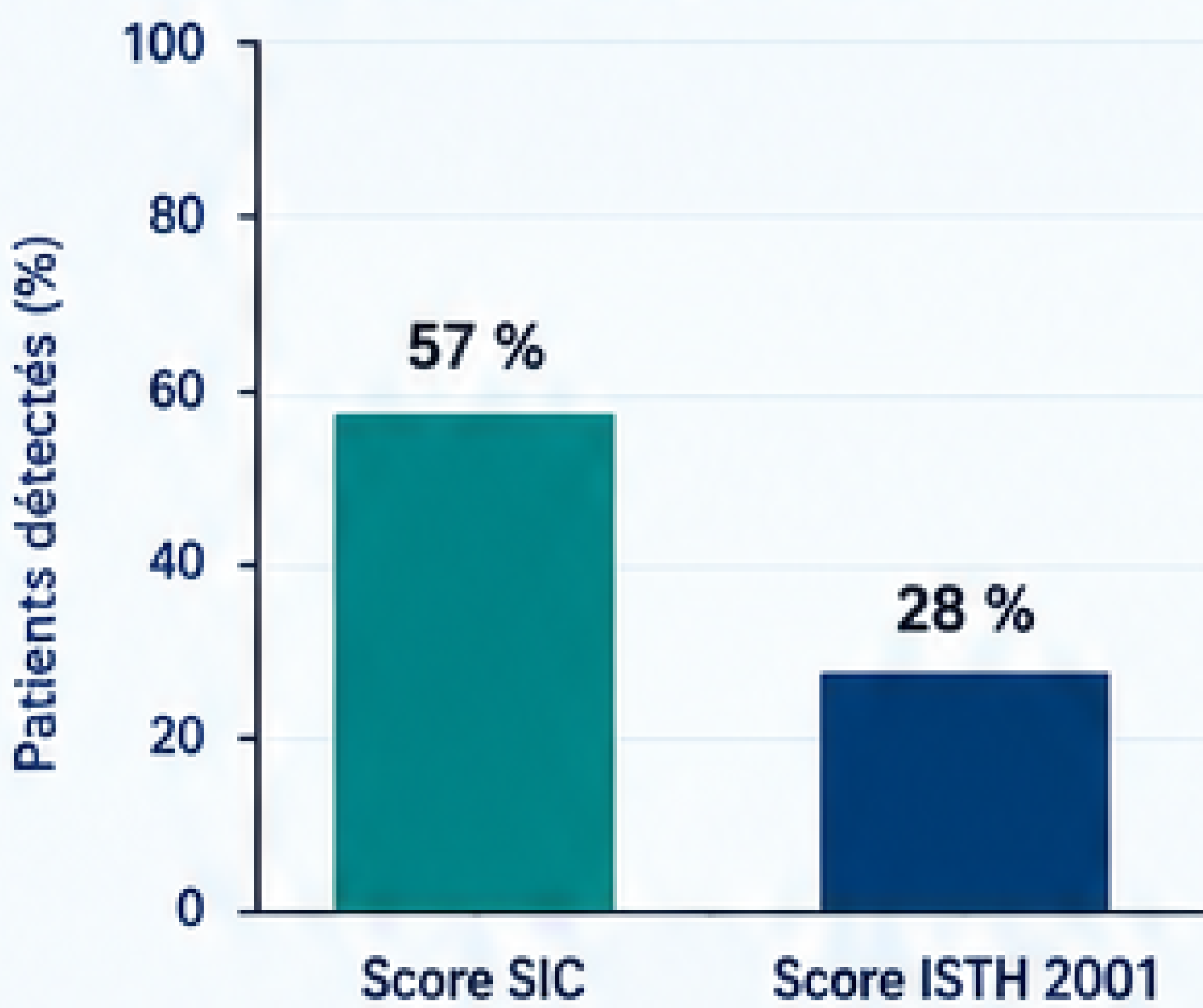


Sensibilité accrue au prix d'une spécificité moindre.



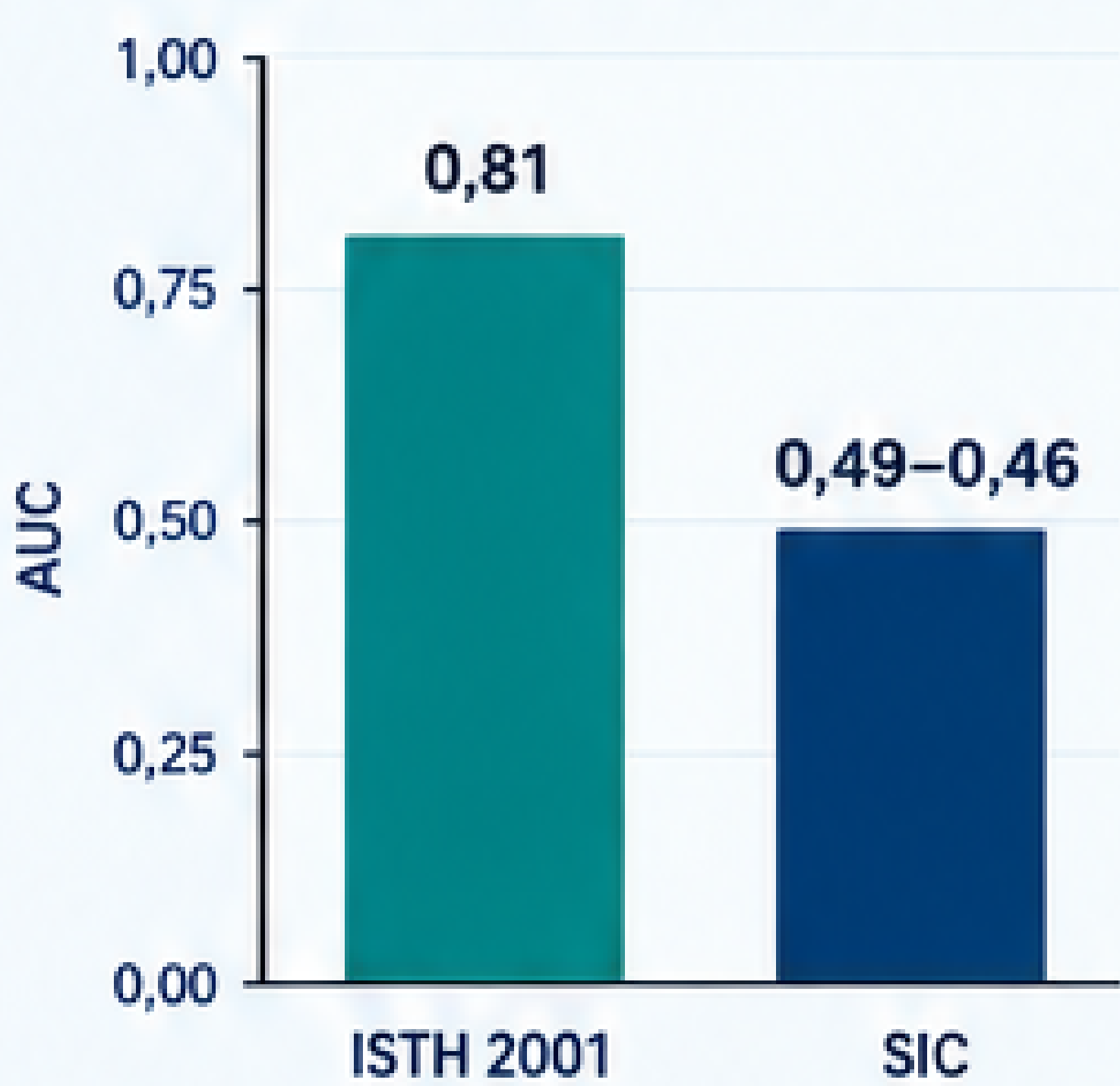
Dans une méta-analyse de 9 319 patients septiques, le score SIC détecte davantage de patients que l'ISTH (57 % vs 28 %), tandis que l'ISTH conserve une meilleure spécificité pronostique (0,81 vs 0,49–0,46).

DÉTECTION PRÉCOCE CHEZ LES PATIENTS SEPTIQUES (MÉTA-ANALYSE, N = 9 319)



Le score SIC détecte significativement plus de patients que l'ISTH 2001 (57 % vs 28 %).

SPÉCIFICITÉ PRONOSTIQUE (AIRE SOUS LA COURBE – AUC)



L'ISTH 2001 conserve une meilleure spécificité pronostique (AUC 0,81 vs 0,49–0,46).

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES CRITÈRES ISTH 2025

ASPECTS	CRITÈRES ISTH 2025
Définition	Processus dynamique avec phases précoce (aiguë) et patente (établie).
Approche	Évaluation en deux temps : dépistage (screening) puis confirmation (confirmatory).
Sensibilité	Améliorée pour détecter précocement les coagulopathies débutantes.
Spécificité	Moins élevée que l'ISTH 2001, mais acceptable dans une stratégie de dépistage.
Adaptation étiologique	Prise en compte du contexte clinique et de l'étiologie sous-jacente (ex. sepsis, cancer, obstétrique).
Pronostic	L'ISTH 2001 reste supérieur pour la valeur pronostique.



DISCUSSION / CONCLUSION



Les critères ISTH 2025 constituent une avancée conceptuelle majeure, corrigeant la détection tardive du score de 2001 et intégrant la variabilité étiologique de la CIVD.

Leur supériorité diagnostique mesurée reste à confirmer par des études prospectives indépendantes, en l'absence de gold standard universel.